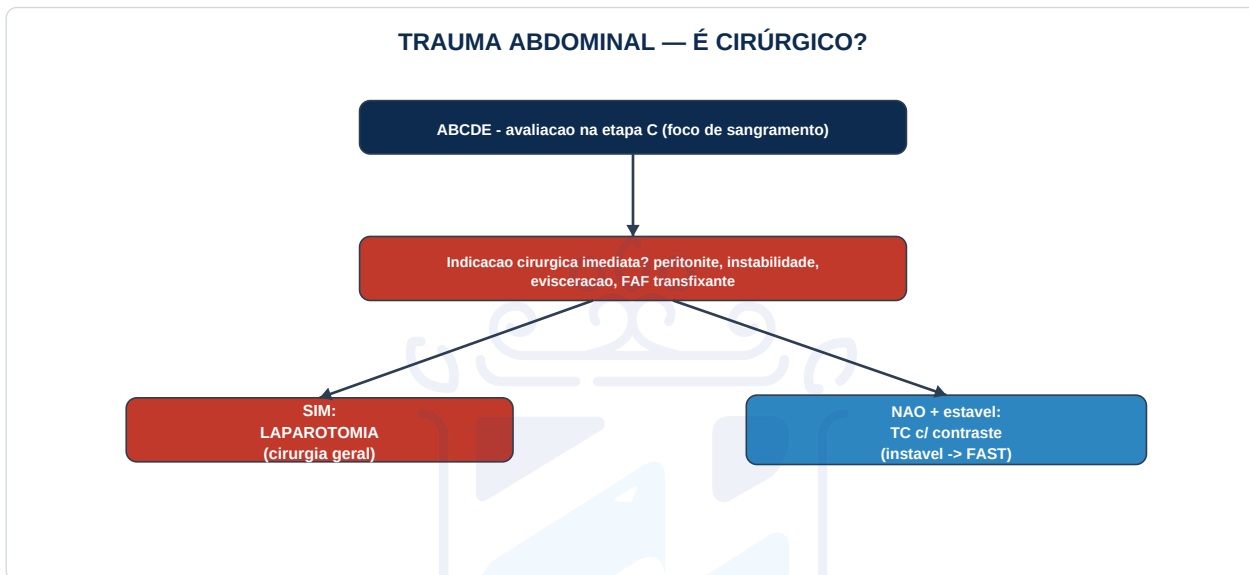


TRAUMA ABDOMINAL — CONTUSO x PENETRANTE

FLUXOGRAMA — ESTABILIDADE DECIDE



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Causa PREVENÍVEL de morte; avaliar na etapa C do ABCDE (controle de sangramento)
- Mecanismo: PENETRANTE (arma branca/fogo) ou CONTUSO
- Diagnosticar e tratar precocemente o sangramento intra-abdominal
- FAST e TC são complementares; a ESTABILIDADE hemodinâmica define a via de investigação

RED FLAGS — INDICAÇÃO CIRÚRGICA IMEDIATA (LAPAROTOMIA)

ABDOME CIRÚRGICO

- Peritonite clara e persistente
- INSTABILIDADE hemodinâmica com fonte abdominal
- Hematêmese / sangue retal (lesão de víscera oca)
- Evisceração ou empalamento; ferimento por arma de fogo TRANSFIXANTE
- Pneumoperitônio ou hérnia diafragmática traumática
- Lesão de víscera oca por arma de fogo = SEMPRE cirúrgica

PENETRANTE — CONDUTA POR REGIÃO

Cenário	Conduta
Indicação cirúrgica presente	Laparotomia (cirurgia geral)
FAB abdome anterior, sem indicação	Exploração LOCAL do ferimento (estéril); se atinge peritônio -> laparotomia; se não -> sutura + observação
FAB/FAF flancos e dorso	TC com triplo contraste (musculatura espessa dificulta avaliar trajeto)
FAF sem indicação cirúrgica	TC de abdome total com contraste (avaliar trajeto; possível tratamento não operatório)
Transição toracoabdominal	Laparoscopia/videotoracoscopia diagnóstica (excluir lesão diafragmática)

CONTUSO — ESTÁVEL x INSTÁVEL

Situação	Conduta
Indicação cirúrgica (peritonite/instabilidade)	Laparotomia
Estável (exclusivo ou politrauma)	TC com contraste + exame físico; tratar conforme achados
Politrauma INSTÁVEL	FAST: positivo -> laparotomia; negativo -> provável causa não abdominal da instabilidade
Sinais de alta energia	Cinto de segurança, fratura de fêmur/pelve, hematúria, TGO/TGP>130, Ht<30% -> TC

TRATAMENTO NÃO OPERATÓRIO (TNO)

QUANDO É POSSÍVEL

- Menor morbimortalidade em casos selecionados; evita laparotomias não terapêuticas
- Vísceras PARENQUIMATOSAS candidatas: fígado, baço, pâncreas, rim/adrenal, bexiga extraperitoneal
- Requisitos: centro com UTI e cirurgião 24h, TC, banco de sangue, lab, endoscopia, (idealmente) radiologia intervencionista
- Monitorização + exame físico + controle laboratorial SÉRIADOS
- Ausência de outras indicações cirúrgicas e de lesões associadas (ex.: TCE) que impeçam observação
- TC é RUIM para avaliar diafragma e vísceras ocas — manter alta suspeição

CONDUTA NO PS

PASSOS

- ☐ ABCDE; na etapa C, identificar o abdome como fonte de sangramento
- ☐ Instável + FAST positivo = laparotomia (não atrasar com TC)
- ☐ Estável = TC com contraste para caracterizar lesões e considerar TNO
- ☐ Penetrante: aplicar critérios de indicação cirúrgica; FAB anterior pode ter exploração local
- ☐ Não introduzir objetos às cegas no ferimento; acionar cirurgia geral

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma abdominal ____ (contuso/penetrante - FAB/FAF) por _____. Estabilidade: _____.
- FAST: positivo/negativo; TC: _____; indicação cirúrgica: peritonite/instabilidade/evisceração/transfixante?
- Conduta: laparotomia / TNO com monitorização seriada.
- Solicito transferência a centro com cirurgia geral 24h / UTI / banco de sangue (estabilizar antes).



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Politraumatizado instável, FAST positivo para líquido livre abdominal. Conduta?

- A) Tomografia de abdome antes de qualquer medida
- B) Laparotomia exploradora (controle do sangramento)
- C) Tratamento não operatório com observação
- D) Alta com analgésico
- E) Apenas exploração local do ferimento

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual achado indica laparotomia imediata no trauma abdominal?

- A) Dor leve à palpação
- B) Peritonite clara, instabilidade hemodinâmica, evisceração ou FAF transfixante
- C) Hematúria microscópica isolada
- D) Escoriação na parede
- E) FAST negativo

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Em paciente ESTÁVEL com trauma abdominal contuso, qual o exame de escolha?

- A) FAST isolado
- B) Tomografia de abdome com contraste
- C) Radiografia simples
- D) Laparotomia
- E) Ressonância magnética

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Quais órgãos são candidatos ao tratamento não operatório no trauma abdominal estável?

- A) Visceras ocas (intestino, cólon)
- B) Visceras parenquimatosas (fígado, baço, rim) em centro com suporte adequado
- C) Diafragma
- D) Esôfago
- E) Nenhum

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre a TC no trauma abdominal, qual limitação é importante?

- A) Não avalia o fígado
- B) É ruim para avaliar diafragma e vísceras ocas diretamente
- C) Não detecta líquido livre
- D) Não avalia o baço
- E) Não serve para planejamento cirúrgico

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

No politraumatizado INSTÁVEL com FAST positivo, indica-se laparotomia exploradora imediata para controle do sangramento — não se atrasa para fazer TC. A TC fica para o paciente estável.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Peritonite clara e persistente, instabilidade hemodinâmica de fonte abdominal, evisceração/empalamento e FAF transfixante são indicações de laparotomia imediata.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

No trauma abdominal contuso em paciente ESTÁVEL, a TC com contraste é o exame de escolha, caracterizando as lesões e permitindo considerar tratamento não operatório.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

O TNO aplica-se a lesões de vísceras PARENQUIMATOSAS (fígado, baço, pâncreas, rim/adrenal) em paciente estável, com centro de referência (UTI, cirurgião 24h, TC, banco de sangue) e monitorização seriada.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A TC é limitada para avaliar diretamente o diafragma e as vísceras ocas — daí a necessidade de alta suspeição clínica e, na transição toracoabdominal, de laparoscopia/videotoroscopia diagnóstica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico